SDD 226 : Sujet n°X

Spécialité : Neurologie

Date : 16/01/2024
Auteur : Nolwenn BILLET (DES de neurologie - ECN 2022)
Relecteur(s) : Lucie-Lou VIAL (EDN 2024 MAR Toulouse)

Domaine d'apprentissage principal	Iconographie
Domaine d'apprentissage secondaire	Urgence vitale
Item(s) en lien avec la station	N°340 Accidents vasculaires cérébraux
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 226 (anomalie du cerveau à l'examen d'imagerie médicale) SDD 233 (identifier/reconnaître les différents examens d'imagerie)
Matériel nécessaire à la station	Iconographie (IRM)
Contexte de la station	Analyse d'un résultat d'imagerie et discussion d'une prise en charge thérapeutique en urgence.

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes neurologue de garde en USINV.
Vous venez de recevoir Madame M, âgée de 72 ans, adressée par les pompiers et qui présente une hémiplégie gauche, anesthésie de l'hémicorps gauche et une négligence de l'hémicorps gauche apparues brutalement et ayant débuté 1h30 auparavant d'après son mari présent sur les lieux.

Constantes : FC 89 bpm, TA 209/104, SpO2 96% en air ambiant, glycémie 7,8 mmol/L.

Elle a pour antécédents une hypertension artérielle, une dyslipidémie et une prothèse de hanche à droite opérée il y a 5 ans.

Dans ce contexte, vous avez demandé en urgence une IRM cérébrale dont vous venez d'obtenir les résultats, disponibles en annexe. Elle présente un AVC ischémique sylvien droit.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Enoncer votre prise en charge à court terme
- Enoncer les mesures médicamenteuses et non médicamenteuses à mettre en place dans ce contexte

Vous ne devez pas :

- Rédiger d'ordonnance
- décrire les imageries

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA

GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques			
1.	Décider d'hospitaliser la patiente en USINV	1 pt	☐
2.	Proposer la réalisation d'une thrombolyse	2 pt	☐
3.	Justifier du délai de réalisation de la thrombolyse	0,5 pt	☐
4.	maintien allongé	1 pt	☐
5.	Proposer la réalisation d'une thrombectomie	2 pt	☐
6.	Prise en charge des ACSOS	1 pt	☐
Communications et attitudes			
1.	**12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

2.	**8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

3.	**6. COMMUNICATION AVEC LES PAIRS (clarté de communication)**	1 pt	

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Est incapable de communiquer le message	Est capable de communiquer les principaux messages, n'arrive pas à les justifier	Est capable de communiquer les principaux messages et justifier son raisonnement	Communique les informations pertinentes et les justifie. Ne s'attarde pas à de l'information inutile	Relie les informations provenant des domaines différents faisant preuve d'une maîtrise du sujet

Éléments de rétroaction :

Face à un déficit neurologique brutal, l'hypothèse vasculaire avec un AVC doit toujours être évoqué en urgence. En fonction des disponibilités des hôpitaux le patient peut être adressé directement en USINV ou bien aux urgences les plus proches pour réaliser une imagerie.

Cette dernière est obligatoire avant d'envisager un traitement, l'IRM cérébrale est l'examen de première intention avec séquences Diffusion (et ADC), FLAIR, TOF, T2* +/- une séquence injectée permettant de visualiser les TSA.

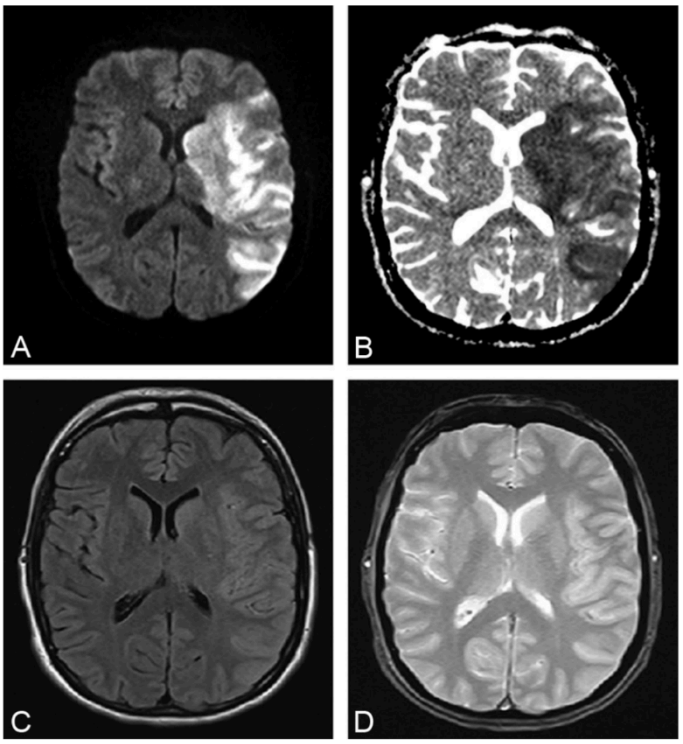

Fig. 27.11. B Séquences IRM visualisant l'infarctus cérébral : infarctus cérébral sylvien gauche à la phase précoce.
A. Hyperintensité en séquence de diffusion. B. Hypointensité (œdème cytotoxique) en séquence ADC (coefficient apparent de diffusion). C. Imagerie subnormal en séquence FLAIR. D. Absence d'anomalie en séquence T2*. (Source : CEN, 2019.)

Malheureusement, l'IRM n'est pas toujours disponible et peut donc être remplacée (dans un premier temps) par un scanner sans et avec injection pour l'analyse des TSA.

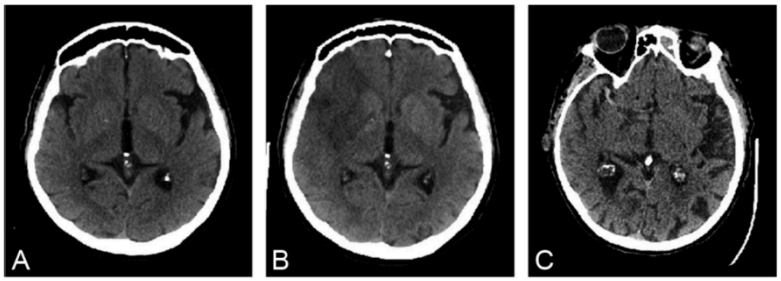

Fig. 27.10. B **Signes précoces d'ischémie cérébrale en scanner : infarctus cérébral sylvien droit. A. Scanner cérébral normal. B. Hypodensité systématisée au territoire sylvien, effacement partiel du noyau lenticulaire et effacement des sillons corticaux hémisphériques droit. C. Hyperdensité spontanée de l'artère cérébrale moyenne droite (signe de la sylvienne blanche).**
(Source : CEN, 2019.)

La prise en charge en urgence repose sur une hospitalisation en neurovasculaire et la prise en charge des ACSOS en premier lieu. Ensuite en fonction de l'étiologie de l'AVC peuvent-être réalisées en l'absence de contre-indication des thérapies de reperfusion (thrombolyse IV et thrombectomie par voie endovasculaire). Ces dernières peuvent être réalisées seules ou en combinaison.

B: Admission en USINV et mesures associées	• Positionnement: 0 à 30° • Perfusion: Sérum salé iso • TA – Absence Thrombolyse: 220/120 mmHg – Post-TLY ou TM: 185/110 mmHg – Lutte contre l'hypotension • Glycémie: > 0,5g/l et < 1,8 g/l • Température < 38°C • SaO2> 94 % • Fréquence cardiaque à contrôler	• Surveillance NIHSS • Surveillance Vigilance • Bilan déglutition • Nursing • Prévention TVP – Compression pneumatique intermittente – ou HBPM précoce • Pas d'antibiothérapie préventive • Pas d'antiépileptique préventif

Fig. 27.13. A **Stratégie thérapeutique de la phase aiguë de l'infarctus cérébral. A. Recanalisation par thrombolyse et/ou thrombectomie mécanique. B. Mesures associées mises en place au sein de l'unité neurovasculaire.**
(Source : CEN, 2019.)